

# *Historia Clínica*

## **Ficha de identificación**

**Nombre:** Juan Ramón Medina Jiménez.

**Edad:** 66 años.

**Sexo:** Masculino.

**Lugar de residencia:** Casa Hogar para Adultos Mayores "Santa María".

**Servicio:** Estancia permanente.

## **Motivo de valoración**

Paciente masculino adulto mayor que recibe seguimiento médico por diversas enfermedades crónicas, destacando hipertensión arterial sistólica aislada e hiperplasia prostática. Durante una valoración previa presentó episodios de mareo y náuseas, además de cifras tensionales bajas, por lo que se realizaron estudios complementarios. Actualmente se encuentra sin sintomatología aguda y bajo vigilancia médica continua.

## **Antecedentes personales patológicos**

El paciente cuenta con antecedentes de:

- Hipertensión arterial sistólica aislada.
- Hiperplasia prostática grado IV.
- Trastorno del desarrollo psicomotriz.
- Lumbalgia crónica secundaria a escoliosis.
- Tricotilomanía y tricofagia.
- Infecciones urinarias recurrentes.
- Nefrosis secundaria a hiperplasia prostática.
- Lesión subepicárdica compatible con IAMCEST en estudio.

En la valoración geriátrica se considera:

- Paciente frágil.
- Alto riesgo de caídas.
- Riesgo bajo de desarrollar lesiones por presión.

## Exploración física

Durante la exploración se encontró paciente consciente, orientado y cooperador, sin datos de enfermedad aguda. Presenta adecuada hidratación y coloración de piel y mucosas.

Cabeza y cuello sin alteraciones aparentes; pupilas reactivas a la luz; cavidad oral hidratada. Tórax simétrico, con adecuada ventilación pulmonar y ausencia de ruidos respiratorios anormales. Ruidos cardiacos rítmicos, sin agregados.

Abdomen blando y depresible, sin dolor a la palpación ni datos de irritación peritoneal.

Extremidades íntegras, sin edema, con disminución de la fuerza muscular y presencia de escoliosis con acortamiento del miembro pélvico derecho.

## Signos vitales

- Presión arterial: 124/74 mmHg.
- Frecuencia cardiaca: 80 lpm.
- Frecuencia respiratoria: 20 rpm.
- Saturación de oxígeno: 97%.
- Temperatura: 37 °C.
- Glucemia capilar: 158 mg/dl.

## Estudios realizados

Se efectuó un electrocardiograma de 12 derivaciones, observándose ritmo sinusal y elevación del segmento ST en derivaciones precordiales, compatible con lesión subepicárdica sugestiva de IAMCEST anterior, recomendándose correlación con marcadores cardíacos y estudios bioquímicos.

Además, estudios radiológicos identificaron litiasis vesicular, por lo que se considera la posibilidad de manejo quirúrgico. Se mantiene seguimiento de la hiperplasia prostática mediante estudios de laboratorio y ultrasonido prostático.

## Plan de cuidados

- Continuar vigilancia clínica.
- Mantener tratamiento antihipertensivo y prostático.
- Monitorear función renal y urinaria.
- Continuar rehabilitación física.
- Realizar estudios de laboratorio y gabinete programados.
- Vigilar la aparición de complicaciones y reportar cambios en el estado de salud.

# Tabla de valoración

| Datos subjetivos                                 | Datos objetivos                                             | Datos históricos                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Refiere antecedentes de mareos y náuseas.        | PA 124/74 mmHg.                                             | Hipertensión arterial sistólica aislada.               |
| Antecedente de lumbalgia crónica.                | FC 80 lpm.                                                  | Hiperplasia prostática grado IV.                       |
| Sin síntomas agudos al momento de la valoración. | FR 20 rpm.                                                  | Trastorno del desarrollo psicomotriz.                  |
| Refiere molestias lumbares.                      | SatO <sub>2</sub> 97%.                                      | Tricotilomanía y tricotofagia.                         |
|                                                  | Temperatura 37 °C.                                          | Infecciones urinarias recurrentes.                     |
|                                                  | Glucemia 158 mg/dl.                                         | Escoliosis y acortamiento del miembro pélvico derecho. |
|                                                  | ECG con elevación del ST sugestiva de lesión subepicárdica. | Riesgo alto de caídas y fragilidad geriátrica.         |
|                                                  | Disminución de fuerza muscular.                             | Litiasis vesicular y nefrosis secundaria.              |
|                                                  | Paciente consciente, orientado y cooperador.                | Seguimiento permanente en casa hogar.                  |